

18 - 06- PURPURA RHUMATOÏDE DE L'ENFANT - Pr. Aït Sab

(0:00 - 0:12)

On va parler du purpura arématoïde chez l'enfant. Le purpura arématoïde chez l'enfant, c'est une pathologie fréquente. C'est une pathologie généralement bénigne.

(0:12 - 0:19)

Il faut la connaître. C'est un diagnostic très facile. Mais le problème, il réside au niveau du ras.

(0:19 - 0:31)

Il y a des complications digestives. Donc, à la fin de ce cours, vous devez être capable de réunir les arguments cliniques en faveur du purpura arématoïde. Savoir poser les indications du bilan paraclinique.

(0:32 - 0:38)

Connaître les diagnostics différentiels. Et c'est très, très important. Je vais insister sur la périarthrite noueuse.

(0:39 - 0:57)

Il faut savoir dépister les complications aiguës et suivre l'évolution à la recherche d'une atteinte rénale à long terme. Et il faut connaître les principes de traitement. Alors, pour définir le purpura arématoïde, il faut tout d'abord dire que c'est la vascularite la plus fréquente chez l'enfant de 5 à 15 ans.

(0:57 - 1:03)

C'est pour ça que j'ai insisté. Je vous ai dit que c'est une pathologie qui est fréquente. Elle est le plus souvent bénigne.

(1:03 - 1:27)

Qu'est-ce qu'elle associe ? Elle associe une triade des syncutanées faites de purpura, un syndrome douloureux abdominal et des manifestations articulaires faites d'arthralgie. Donc, purpura, douleur abdominale et arthralgie, c'est un purpura arématoïde chez l'enfant. Mais le pronostic, il est dans le rouge.

(1:27 - 1:52)

L'atteinte rénale qui est présente chez 30% des cas et qui fait le pronostic de la maladie. Il faut la chercher à chaque fois que vous avez un tableau de purpura. Concernant l'épidémiologie, c'est

une pathologie toujours de l'âge scolaire, 4 à 7 ans, 80% des cas, et 15 à 20 cas pour 100 000 enfants de moins de 15 ans.

(1:52 - 2:02)

Ça, c'est sa fréquence. Tout âge est concerné. Alors, je vous ai dit, c'est l'âge scolaire, mais on peut l'avoir également chez l'adulte.

(2:02 - 2:23)

Et chez le nourissant, il fait une forme très particulière qu'on appelle l'œdème aiguë hémorragique. Je vais vous montrer une photo d'un nourissant qui fait un œdème aiguë hémorragique. C'est une pathologie qui se caractérise par un contraste énorme entre les lésions cutanées et l'état général du bébé.

(2:24 - 2:51)

La prédominance masculine est discrète, et dans un tiers des cas, on retrouve une infection des voies aériennes supérieures préexistantes, mais sans qu'on puisse faire le lien évident entre l'infection et la pathologie. Le caractère épidémique saisonnier, on a une recrudescence le plus souvent hivernale. C'est ça qui renforce un petit peu l'idée de cette infection des voies aériennes supérieures.

(2:52 - 3:14)

On commence à cette période-là d'avoir beaucoup de cas. La physiopathologie, c'est une vascularite leucocytoclasique des vaisseaux du derme ou des viscères. Les vaisseaux du derme, c'est ce qui vous donne le purpurin, et les viscères, bien sûr, c'est le tube digestif et le neurone, à côté d'autres organes, bien sûr, qui peuvent être atteints.

(3:14 - 3:25)

Ça, on va voir, comme les testicules, etc. Le mécanisme, il est immunoallergique. Il y a un infiltrat inflammatoire avec une nécrose fibrinoïde de la paroi des vaisseaux.

(3:26 - 3:40)

Donc, c'est ça ce qui fait la vascularite leucocytoclasique. La pathogénie, elle est précise, reste encore inconnue. Il y a, c'est une pathologie, c'est ce qu'on appelle, quand elle s'accompagne d'atteinte rénale, on dit néphropathie à IGA.

(3:41 - 4:02)

Et dans les néphropathies à IGA, je vous ai parlé de la maladie de Verger et du purpurin rhumatoïde. Il y a des complexes immunes circulants, donc il y a une augmentation des IGA, et

ces IGA-là, ils vont se déposer au niveau de la paroi capillaire. Et quand on fait une biopsie, soit cutanée, soit rénale, il faut demander une immunofluorescence qui atteste la présence de ces immunoglobulins.

(4:03 - 4:22)

Donc, au niveau de la peau, au niveau du tube digestif, et au niveau du mésingien, cliniquement. La présentation habituelle, c'est un purpurin qui s'installe en quelques heures ou quelques jours. Alors, la durée de la maladie, elle est variable.

(4:23 - 4:52)

C'est soit une poussée, une seule, dans un tiers des cas, qui évolue sur deux à trois semaines, ou bien ça peut se manifester sous forme de plusieurs poussées, dans deux tiers des cas, qui se succèdent pendant deux à trois mois ou plus. Quand on a une seule poussée, elle peut être grave, elle peut donner une atteinte rénale, mais c'est surtout quand vous avez plusieurs poussées, c'est là où le risque d'atteinte rénale devient très important. À chaque fois, le risque, il est corrélé au nombre de rechutes.

(4:54 - 5:07)

Pour les signes généraux, alors, on a une petite fièvre, parfois le plus souvent, les maladies sont apéritiques. Et cette fièvre, elle est généralement modérée. C'est ça qui fait la différence avec le diagnostic différentiel, qui est la périarthrite noueuse.

(5:07 - 5:20)

Et cette fièvre, elle peut être présente au début ou lors des poussées. Généralement, je vous le dis, c'est des malades qui ne sont pas réputés être fébriles. Les marqueurs biologiques de l'inflammation, ils sont discrètement modifiés.

(5:21 - 5:42)

Donc là, c'est aussi l'élément contre le diagnostic différentiel, qui est la périarthrite noueuse et les autres. Cliniquement, on a des manifestations, on a parlé du purpurin, et donc ce purpurin, c'est un purpurin vasculaire. Et qui dit purpurin vasculaire, dit purpurin infiltré.

(5:42 - 5:58)

Ce n'est pas comme le purpurin uniquement pétéchial, qui est le purpurin thrombopénique. Là, c'est infiltré. Donc, il faut savoir examiner vos enfants et voir s'ils ont une infiltration, une induration de ce purpurin.

(5:59 - 6:13)

Et donc, c'est ça qui témoigne de l'origine vasculaire. Ce purpurin, il peut confluer en plaques équimotiques. Il peut être sous forme de macules, de papules, de plaques urticariennes, d'œdèmes douloureux localisés.

(6:13 - 6:47)

C'est ce qu'on va voir, par exemple, chez le nourissant et dans les arthritides, etc., dans les œdèmes infiltrant les membres inférieurs, qui se voient au niveau des pieds, au niveau des mains, au niveau du scrotum, et ça fait mal. L'élément essentiel de ce purpurin, qui est infiltré, la deuxième caractéristique, c'est que c'est un purpurin orthostatique, qu'on dit, avant, on l'appelait déclivire, c'est-à-dire en position debout, il s'aggrave. Pourquoi ? Parce qu'en position debout, vous avez un retour veineux.

(6:47 - 6:53)

Le sang, il est attiré par l'orthostatisme. Et donc, vous avez une dilatation des vaisseaux. Ce sont des vaisseaux qui sont fragiles.

(6:53 - 7:05)

Donc, il y a une extravasation du sang en dehors des capillaires. Et c'est ça ce qui aggrave, qui donne le purpurin. Il se voit au niveau des membres inférieurs, au niveau des coudes, au niveau des avant-bras.

(7:05 - 7:16)

Quand le malade, il est couché, en position couchée, une caractéristique, c'est qu'il est rare au niveau du tronc et sur la face. Donc là, il est rare sur le tronc et la face. Et parfois, on a des localisations.

(7:16 - 7:41)

Donc, en position debout, c'est les membres inférieurs, les fesses, etc. En position couchée, c'est les fesses, c'est le dos, et c'est la face postérieure, les avant-bras. Et il y a d'autres localisations qui sont atypiques, scrotales, au niveau de la verge et au niveau des pavillons des oreilles, quand le malade, bien sûr, il est en position couchée, décubitus dorsal.

(7:41 - 7:56)

Ces lésions, elles se constituent en 3 ou 4 jours. Et on peut retrouver des éléments d'âge différents. Ils régressent en général en 1 à 3 semaines ou évoluent par poussées plus ou moins nombreuses et durables déclenchées par la reprise de l'activité.

(7:57 - 8:07)

Et c'est pour ça qu'on met ces malades au... Voilà donc quelques photos. Là, c'est un malade du service. Regardez l'aspect, donc, du pur curat qui devient parfois équimotique.

(8:07 - 8:19)

Là, c'est pété chial. Et vous avez ici une petite nécrose qui n'est pas très méchante et qui ne fait pas, bien sûr, penser au diagnostic. Regardez, c'est le même enfant.

(8:19 - 8:27)

Vous avez les deux membres intérieurs. Donc, vous voyez l'aspect orthopédique. Regardez cette forme-là qui est encore plus importante.

(8:27 - 8:37)

Vous avez des plaques ici, des plaques qui simulent urticariennes, comme des plaques urticariennes. Donc, le pur curat, il devient confluent. Et vous avez ici une petite zone de nécrose.

(8:38 - 8:43)

Là aussi, c'est la même malade. C'est une malade du service. Et donc, vous voyez la confluence des lésions.

(8:44 - 8:58)

Et vous avez le siège au niveau inférieur. Là, c'est une photo prise sur Internet qui vous montre, si vous regardez bien, l'aspect enduré du pur curat. Là aussi, c'est une photo, donc, prise sur Internet.

(8:59 - 9:14)

Et vous voyez, donc, l'aspect confluent. Ah, toujours la même chose au niveau des membres intérieurs. Vous avez l'aspect pentiforme, pétéchial, et l'aspect confluent des lésions avec des petites zones de nécrose.

(9:16 - 9:21)

Ah, la place postérieure. Là aussi, c'est un malade, donc, du service. La même chose ici.

(9:22 - 9:26)

Donc, c'est un nourissant du net. Ce n'est pas un artiste. C'est le même nourissant.

(9:27 - 9:46)

Et là, j'ai pris cette photo pour vous montrer ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'aspect simulant

une arthrite avec un œdème de l'extrémité inférieure du membre qui, parfois, est très douloureux. Ça, c'est un malade du service. Et vous voyez, ça, c'est ce que vous devinez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'œdème aiguë hémorragique du nourissant.

(9:47 - 10:01)

Regardez l'aspect des lésions. Regardez l'aspect des lésions, l'étendue des lésions, la confluence des lésions, nécrotique par endroits. Et regardez le bébé qui est là, heureux, joyeux, en train de jouer avec ses membres inférieurs.

(10:01 - 10:12)

Et c'est ça ce que je vous ai dit, la caractéristique de cette maladie, le contraste entre l'état général et l'aspect des lésions qui fait peur. Les manifestations. Donc, on a vu les manifestations cutanées.

(10:12 - 10:18)

Maintenant, on va voir les manifestations articulaires. Elles se voient dans deux tiers des cas. Elles ne sont pas constantes.

(10:18 - 10:31)

Et elles peuvent précéder la symptomatologie, c'est-à-dire précéder le purpura. Et c'est ça ce qui fait, parfois, errer le diagnostic dans le purpura rémat. Oui, c'est quand vous avez un élément qui précède, qui n'est pas associé aux autres.

(10:31 - 10:49)

Soit la symptomatologie digestive qui amène le malade au bloc, soit la symptomatologie articulaire, qu'on ne prend pas pour arthrite juvénile idiopathique ou pour arthrite infectieuse. Soit les manifestations, soit le purpura tout seul qui peut prêter à confusion avec les manifestations hématologiques. Donc, il faut faire attention.

(10:50 - 11:01)

Et donc, comme j'ai dit, elle peut précéder, accompagner ou suivre l'atteinte cutanée. Elle est faite généralement d'arthralgie. Rarement des arthrites, elles sont bilatérales et symétriques et ne gardent pas de séquelles.

(11:01 - 11:11)

Elles sont non déformantes. Je le dis, je le redis. Elle atteint les grosses articulations généralement, les chevilles, les genoux, et elles durent moins que le purpura lui-même.

(11:11 - 11:20)

3 à 5 jours et disparaissent sans laisser de séquelles. Donc, il faut savoir chercher un interrogatoire. Regardez ici, c'est le bébé que je vous ai montré tout à l'heure.

(11:21 - 11:40)

Ça, c'est l'aspect de l'arthrite avec l'œdème infiltrant qui fait mal et vous voyez la confluence des lésions. Alors, concernant le troisième signe, ce sont les manifestations digestives. Alors, vous imaginez ce que vous avez au niveau de la peau, vous allez la voir au niveau de l'épithélium digestif.

(11:41 - 11:50)

Et donc, c'est traduit l'équivalent mieux que du purpura. Plus de 50% des cas, parfois révélatrice. Et ça, c'est un piège diagnostique.

(11:50 - 12:04)

Il y a plein de purpuras rhumatoïdes qui ont été opérées pour appendicite pour histoire chirurgicale. Donc, ce sont des douleurs intenses, des couliques aiguës, paroxystiques. Donc, chez le nourissant, ils peuvent simuler l'invagination intestinale aiguë.

(12:05 - 12:20)

Faites attention, c'est des douleurs, parfois, qui sont très, très, très atroces et qui peuvent amener, par erreur, le malade au bloc. Mais bien sûr, je ne parle pas de purpura, c'est-à-dire des douleurs abdominales. Dans le cadre du purpura rhumatoïde compliqué d'invagination intestinale, on va voir ça.

(12:21 - 12:39)

Là, je vous dis, quand les manifestations digestives arrivent en premier, et ils peuvent, bien sûr, parfois simuler un tableau d'appendicite ou autre. Et le malade, il arrive au bloc alors qu'il n'en a pas besoin. Et ça peut donner aussi des vomissements, une diarrhée anorexique.

(12:39 - 12:53)

Ça peut saigner, vous le devinez, et mathémèse, mais surtout, parfois, des mélénas. Et ça peut, bien sûr, se compliquer. Ça peut se compliquer d'invagination, ça peut se compliquer de perforation, de nécrose, etc.

(12:54 - 13:19)

Et si elles sont révélatrices avant les syncytanes, et dans 10 à 15% des cas, problème d'un

abdomen épichururgique, qui peut être diagnostique. Concernant les manifestations rénales, et là, c'est la complication, c'est l'élément pronostique du purpura rhumatoïde. La teinte glomérulaire, elle s'exprime habituellement durant les premières semaines de la maladie, mais parfois plus tardivement, au cours d'une nouvelle poussée.

(13:19 - 13:34)

Donc, quand vous avez un malade qui a un purpura rhumatoïde, il faut dépister initialement la teinte rénale, il faut savoir la rechercher, il faut continuer à la rechercher. Il n'y a pas de corrélation entre la sévérité des signes extra-rénaux et celle de la néphropathie. Je m'explique.

(13:34 - 14:13)

C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a un purpura très étendu, très grave, qu'on aura une teinte rénale très sévère. On peut avoir quelques lésions purpuriques avec une teinte rénale très sévère et vice-versa. Ça se manifeste par une hématurie isolée, macroscopique ou microscopique, et il est le signe le plus fréquent et le plus accompagné d'une protéine urimodérée généralement qui n'est pas néphrotique.

Quand ça devient un syndrome néphrotique, ça devient grave. L'insuffisance rénale transitoire est possible et l'HTA est rare, mais peut être noté, même en présence de signes urinaires minimes. C'est pourquoi je vous ai dit que la corrélation entre la CVVT des signes extrarénaux et rénaux n'est pas de fait.

(14:14 - 15:00)

Les autres manifestations, je vous ai dit qu'il y a la peau, le tube digestif et le ras, mais il y a d'autres atteints, cette vascularite leucocytoclasique, elle peut toucher le système nerveux, donc se donner des complications neurologiques qui vont se manifester sous forme de convulsions, confusions, paralysies faciales ou sciatiques. Testiculaire, orchite, et là j'attire votre attention, s'il vous plaît, un malade qui fait une orchite dans le cadre d'un purpurhématoïde, c'est la même chose que dans les oreillons, il faut savoir le dire aux parents, parce que quand il grandira et si jamais il n'a pas un problème de fertilité, il faut que ça sorte dans les antécédents. Ça peut aussi se manifester par un hématome scrotal, et je vous ai dit qu'il y a une infiltration de la paroi scrotale.

(15:01 - 16:04)

Ça peut aussi donner des complications cardiaques, ça peut être une myocardite, une péricardite, ça peut être pleuropulmonaire, elles sont moins fréquentes, et parmi les complications urologiques, la nécrose urétérale est très spécifique du purpurhématoïde qui donne une sténose urétérale. Il faut le dire aux patients, il faut savoir la dépister quand on a des signes urologiques, et ça peut aussi infiltrer la paroi viscérale qui va se manifester par hématome.

Ça peut aussi donner des complications pancréatiques parotidiennes, et toutes ces manifestations sont rares et généralement de bon pronostic, sauf si vous avez une atteinte neurologique très sévère et la nécrose urétérale, si elle est bilatérale et donne une sténose bilatérale, ça donne un obstacle bilatéral qui peut bien sûr menacer le rat ou sur un unique, donc il faut faire attention.

L'atteinte cardiaque, elle est grave, mais heureusement elle est rare. Donc faites attention, quand vous examinez ces malades, il faut savoir dépister toutes ces atteintes possibles. Et le mot important, c'est que l'état général est conservé.

(16:04 - 16:22)

Et c'est ça ce qui fait la différence entre le purpurarhématoïde et les autres vascularides. Donc c'est un enfant qui est en bon état général, qui généralement n'est pas fébrile, et qui présente ces signes qu'on a décrits. Alors pour la paraclinique, le diagnostic, il est clinique.

(16:23 - 16:43)

Donc il est fait de la triade, et il est fait du dépistage de l'atteinte rénale. Mais généralement, on n'a pas besoin de bilan, sauf pour chercher les complications. L'anumération, bon, si vous hésitez, mais si je vous ai parlé du caractère infiltré du purpurarhématoïde, l'anumération, elle vient juste vous dire qu'il n'y a pas de thrombopénie.

(16:44 - 17:03)

Le bilan des mostaziles est normal, dans le même sens pour le purpurarhématoïde. La fonction rénale, là par contre, c'est le temps de saignement qui va être allongé, parce que c'est une vascularite. La fonction rénale, il faut l'évaluer, il faut rechercher, il faut dépister l'atteinte rénale, l'ématurie, le protéinurie, et il faut évaluer l'intensité de la protéinurie.

(17:04 - 17:59)

Parfois, on dose le facteur 13, qui est souvent abaissé, qui a une valeur pronostique pour les complications rénales ou digestives, mais il faut dire qu'on ne le fait pas de façon routinière, nous, vu le manque de moyens, et les complications rénales et digestives, on les dépiste par les moyens qu'on a, comme l'échographie pour le type digestif, et bien sûr les bandelettes et la cytologie urinaire et la biopsie pour les complications rénales. Je vous ai dit qu'il y a une synthèse des immunoglobulines A, c'est une pathologie à IgA, donc automatiquement il y a une élévation transitoire de l'IgA, mais là aussi, ce n'est pas un examen de routine. L'ASP, alors vous devinez l'ASP, pourquoi? C'est qu'on a dit qu'il y a un risque de perforation, un risque de sténose, donc un abdomen aigu chirurgical, si on cherchait un pneumopéritoine, etc., les signes de complications digestives.

(18:00 - 19:07)

L'échographie abdominale d'indication large, parce que c'est des tableaux, on va voir dans les complications l'invagination intestinale aiguë, donc il faut savoir poser l'indication d'une échographie, ne pas hésiter à la faire pour ne pas passer à côté d'une invagination intestinale aiguë. La biopsie cutanée, on l'a fait si on a un aspect nécrotique, parce que généralement, ce purpura dans le contexte du purpura rhéматоïde, il est généralement non nécrotique. Petites lésions nécrotiques qui ne sont pas très méchantes, mais si vous avez un aspect nécrotique très important, c'est soit infectieux, soit une autre vascularité, c'est ça l'intérêt de la biopsie cutanée avec la recherche des dépôts d'IGF et de la nature de la vascularité.

Là, c'est ce qu'on voit au niveau du ras, ce que vous voyez en flachant, là, ce sont les dépôts d'IGF au niveau du glomérulaire. Le diagnostic positif, comme je vous ai dit, il est unique. Devant tout purpura orthostatique ou déclive, qui n'est pas thrombopénique, avec des arthralgies, des douleurs abdominales et un bon état général, c'est un purpura rhéматоïde.

(19:08 - 19:25)

Avec quoi ? Bon, dès le départ, je vous parle, attention, attention, on risque de confondre le purpura rhéматоïde avec d'autres pathologies. Si on reste uniquement à la phase clinique, c'est les purpuras thrombopéniques, quelle que soit leur étiologie. Après l'annumération, ce sont les autres purpuras vasculaires.

(19:26 - 19:51)

Alors, j'ai dit infectieux, c'est le purpura méningo-poxique et les autres septicémies, et dans ce cas-là, c'est un purpura extensif, nécrotique, rapidement progressif, dans un contexte fibril, avec altération de l'état général, des signes neuroméningés, etc. Donc, faites attention, là, c'est une grande urgence, c'est un autre chapitre. Le deuxième chapitre, c'est l'étiologie, le purpura vasculaire d'origine immunologique.

(19:51 - 21:28)

Et là, j'insiste sur la périarthrite noueuse. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans le purpura rhéматоïde avec une atteinte rénale et la périarthrite noueuse, on a besoin de faire une biopsie rénale. Dans le purpura rhéматоïde, on fait une biopsie rénale sans aucun problème.

Alors que dans la périarthrite noueuse, on crée la création d'anévrysme, et suite à la biopsie rénale, et dans ce cas-là, on fait le plus souvent une opacification, une visualisation vasculaire avant de faire la biopsie, et c'est ça donc ce qui est grave. Deuxièmement, la périarthrite noueuse, c'est une pathologie où il y a la fièvre, l'altération de l'état général, l'hypertension artérielle. S'il vous plaît, retenez ces éléments.

Elle n'est pas fréquente, c'est-à-dire, c'est pas la fréquence du purpura rhéматоïde, mais il est

grave. Donc, on a fièvre, altération de l'état général, HTA, et puis on a un aspect nicrotique, vraiment nicrotique des lésions. Le lupus, les vascularides du cryoglobulinémie, donc toutes les autres vascularides, ils peuvent traiter à confusion le purpura rhématoïde.

Alors, là, vous devinez automatiquement que c'est un purpura nicrotique, c'est une photo prise sur internet d'un purpura méningococcique nicrotique, dans le contexte d'un purpura. Par contre, je vous montre une photo d'une fillette au service qui présente une périarthrite noueuse. Alors, regardez l'aspect du purpura pétéchiâle, et vous avez ici des bulles nicrotiques.

(21:28 - 21:55)

Vous avez la confluence du purpura avec des lésions qui sont nicrotiques, vraiment hémorragiques et nicrotiques. Donc, regardez l'aspect, c'est ça qui fait la différence, et vous avez un nombre important de lésions nicrotiques. Là, c'est une photo qui est prise sur internet, et si vous arrivez à suivre avec moi, vous pouvez deviner l'aspect modulaire et infiltrant du purpura, qui caractérise la périarthrite noueuse.

(21:56 - 23:26)

Regardez, vous pouvez agrandir l'image et voir cet aspect modulaire pour mouer des lésions. L'évolution. Donc, je vous ai dit que le purpura hématoïde est une pathologie qui guérisse sans complications ni séquelles, en général en deux à trois semaines.

Donc, elle est généralement de bon pronostic, avec possibilité de poussée successive sur quelques semaines à deux ans. Donc, un malade, il peut récidiver son purpura, mais attention, je vous ai déjà dit que l'atteinte rénale, elle est corrélée à ses petits. Les complications.

Alors, pendant la phase aiguë, je vous ai parlé des complications digestives. Elles sont précoces. Vous avez l'invagination intestinale aiguë, qui va se manifester par des douleurs, des rectoragions, une subocclusion.

Il ne faut pas attendre les rectoragions. Attention, devant toute douleur abdominale intense en matière de purpura hématoïde, on demande une échographie, à la recherche de cette invagination, qui est iléo-iléale, à l'encontre de l'invagination habituelle chez le nourissant. Ça peut aussi donner des hématomes intramuraux, surtout du odéno.

Donc, ça peut engendre une intolérance alimentaire. Donc, il faut mettre ces malades au repos digestif. Ça peut se compliquer même d'enthéropathie exudative.

Ça peut saigner. Ça peut sursearrer. Ça peut, bien sûr, entraîner des occlusions.

Ça peut perforer ce nécrosé perforé. Et ça peut bien sûr saigner, comme je dis. À long terme, c'est le rare.

(23:27 - 23:35)

La néphropathie complique moins de 5% des purpuras hématoïdes. Elle représente 15% de l'ensemble des glomerulopathies de l'enfant. Donc, c'est pas rien.

(23:36 - 24:34)

C'est un grand pourcentage des glomerulopathies de l'enfant. Et 25% des cas des formes diffuse ou à rechute multiple pendant les trois premiers mois. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur les rechutes du purpura.

Hématurée, avec protéines minimales, c'est fréquent. On ne fait pas de biopsérimes. On traite le malade, on le prend en charge et on surveille.

Par contre, si on a un syndrome néphrotique, ou une insuffisance rénale, ou on a des choses qui sont importantes et sérieuses au niveau du rat, là, on biopsie parce qu'il y a quand même une classification de la teinte rénale. Il faut traiter les folies infectieuses. La surveillance, elle est simple à long terme.

Car 10 à 20% de complications tardives à titre de protéines importantes, d'HTA, et 5 à 10% arrivent aux insuffisances rénales terminales. Donc, parmi tous les malades qui ont récidivé et tout ça, c'est uniquement 5 à 10% qui vont arriver aux insuffisances rénales. Mais c'est important parce qu'il faut quand même dépister et il faut mettre un traitement qui va stopper et améliorer le pronostic de ces malades.

(24:36 - 25:38)

Donc, chaque fois qu'on a une suspicion d'une atteinte rénale sévère avec un syndrome néphrotique, une protéine supérieure à 1 gramme, ou des insuffisances rénales, ou une HTA qui ne répond pas au traitement et qui s'aggrave, il faut faire une biopsérime pour intensifier le traitement. Il n'y a pas de traitement spécifique. Donc, on a vu que ce ne sont que des traitements symptomatiques.

Le repos, puis reprise progressive. Le repos, je vous l'ai expliqué parce qu'il y a une extravasation du sang par la position debout à cause de l'orthostatisme. Donc, il faut mettre ces malades au repos.

On donne des antalgiques pour l'atteinte articulaire et on donne des antispasmodiques pour l'atteinte digestif. La corticothérapie, elle est indiquée dans les formes digestives sévères, mais s'il vous plaît, attention, avant, normalement, avant de démarrer une corticothérapie chez ces malades, on fait une fibroscopie. On fait une fibroscopie parce que si vous donnez une corticothérapie sur une lésion ulcéreuse, elle va se perforer.

(25:38 - 27:08)

D'accord? Donc, en général, on fait une fibroscopie et on démarre une corticothérapie. Les formes rénales, les formes rénales, là, la corticothérapie, elle est soit par voie orale, si la forme, elle est mineure, soit par bolus, en fonction, bien sûr, de la sévérité, en fonction, parfois, des résultats de la PBR. Et même, vous allez remarquer qu'au service chez nous, par exemple, on commence les protocoles avant même de faire la biopsie pour, bien sûr, sauver les rats.

Et par la suite, on revient, on recherche, bien sûr, la stagification des lésions et on recherche la présence de de dépôts d'immunoglobuline A. Il faut savoir arrêter la nutrition dans les formes digestives sévères, soit la remplacer par un repos digestif si c'est une courte durée, soit par une nutrition parentérale si, bien sûr, on va être lent dans la prise en charge nutritionnelle. Et le traitement immunosuppresseur et les nécroprotecteurs type IEC et AA2, la immunosuppresseur, je parle du cyclophosphamide, je parle du MMF, je parle de là il y a plusieurs protocoles et donc plusieurs médicaments qu'on peut utiliser dans l'atteinte sévère selon un schéma, c'est-à-dire de succession de gravité, on augmente, bien sûr, le potentiel de l'immunosuppression quand on a une atteinte rénale diffuse avec croissance. Bien sûr, le traitement des complications chirurgicales, l'invagination, la perforation, la sténose, etc.